26.006.192-5

18-03

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Mateo Valentino Campos Arévalo				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	24/11/2017	Edad actual	6 años	4 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	El Almendral Los Parrones del Inca, calle Miguel Bienzobas #3065				Teléfono	9345 86 337	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	Kínder	Establecimiento	Liceo Mixto Basica SF				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 04.04.2024	2. Fecha de la entrevista: 04/04/2026.
Nombre: Nicole Arevalo Ordoñez	Nombre: Nicolle Arévalo.
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante: Mamá.
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista: 04.04.2024	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 04.04.2024	2. Fecha de la entrevista: 04/04/2026.
Nombre: Diana Lazcano	Nombre: Carolina Veba.
Rol/cargo: EDI	Rol/cargo: EDI
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Continuidad en Programa de Integración Escolar (PIE)
Evaluación por 3er año.

- Actualización de anamnesis. año 2026.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☑ No ☐ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☑ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO	Peso: 3,950	Talla: 50cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

38 semanas
sin antecedentes de importancia

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	No	Traumatismos	Sí	No	Encefalitis	Sí	No
Obesidad	Sí	No	Intoxicación	Sí	No	Meningitis	Sí	No
Fiebre alta	Sí	No	Enfermedad respiratoria	Sí	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	No	Asma	Sí	No			
Hospitalizaciones	Sí	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	Sí	No		Vacunas	Sí	No

Observaciones: sin observaciones

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 1m	Se sienta sólo/a: 4m	Camina sin apoyo: 1a 1m.
Primeras palabras: 9m	Primeras frases: 1 - 1½ a	Se viste solo/a: 3a

Controla esfínter vesical	Controla esfínter anal
Diurno: 1ª½ Nocturno: 1ª½	Diurno: 1½ a Nocturno: 1½ a

Observaciones: sin observaciones.

En su actividad motora general se aprecia:	**Su tono muscular general se aprecia:**
☑ normal ☑ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Sí	No	Caídas frecuentes	Sí	No	Dominancia lateral	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Sí	No	Prensión	Sí	No	Pinza	Sí	No
Ensarta	Sí	No	Dibuja	Sí	No	Escribe	Sí	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	Sí	No	Manipula y Explora objetos	Sí	No
Demanda objetos y compañía	Sí	No	Comprende prohibiciones	Sí	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Sí	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	No

Observaciones:
Sin observaciones

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No
Observaciones: Tiende a subir el volumen (muy elevadamente) de los objetos que emiten sonidos.					

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma ☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): Cerca de los 2 a nace hermano menor y sufre retroceso en el lenguaje oral.					
Observaciones: Llegando a prekínder recibe primeras atenciones referente a su dif. en el lenguaje expresivo.					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No
Ante los siguientes estímulos su reacción es:					
Luces: ☑ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☑ natural ☐ desmesurada		**Personas extrañas:** ☑ natural ☐ desmesurada		
Observaciones: Sin observaciones					

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	Sí	~~No~~
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
sin observaciones

Alimentación: ☐ normal ☑ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☑ inquieto Horas que duerme: 8- 9 hrs.

☑ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☑ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☑ acompañado
(Especifique): mamá / hermano

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones: sin observaciones

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Nicole Arevolo	Madre	32 a	8 a	Pastelera
2. Josefa Campos	Hermana	15 a	1° medio	Estudiante
3. Simón Campos	Hermano	4 a	Prekínder	Estudiante
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Abuelo materno hipertenso.
Abuela paterna alzhaimer.

Observaciones: sin observaciones.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4a	Asistió a jardín infantil	Sí	~~No~~
Nº de colegios en que ha estudiado	1	Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:		
Motivo de los cambios: —				
Ha repetido curso/s	Sí ~~No~~	Curso(s)	Motivo: —	

Situación actual

Nivel/curso actual	10básico	**Dificultad de aprendizaje**	Sí	~~No~~	**Dificultad para participar**	Sí	~~No~~	**Conducta disruptiva**	Sí	~~No~~
Asiste regularmente	Sí ~~No~~	Asiste con agrado	Sí	~~No~~	Apoyo familiar en tareas	Sí	~~No~~	Amigos (as)	Sí	~~No~~

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☑ ver TV ☑ juguetes ☑ tiempo libre ☐ otro(s)..... celular .....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☑ padre ☑ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Padre lo visita de forma regular.
Desde Diciembre ya no vive en la casa.
Padre lo viene a dejar y a buscar al colegio.
Buena relación con los niños.
Hermana mayor intercede en el contacto con el padre
Padre - madre escasa comunicación.

* Ingresa a LMBSF en prekinder.

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY